Pacient 7 r. č. 723456/7777 poj.

tel.

Mamologie - MDT

Diagnostický souhrn:

V rámci MASC záchyt drobného okrskovitého stínu na rozhraní DKK při bazi žlázy vlevo, sonograficky oválné ložisko 8x3mm v blízkosti submamární rýhy

CCB

Histologie:

Makropopis:
Dodán 1 punkční váleček, délky 0,7 cm a 0,1 cm v průměru, bílobéžové barvy, + drť.
Mikropopis:
a,b) V punkčních válečcích tkáň mléčné žlázy se strukturami P120 cytoplasmaticky a GATA3 jaderně pozitivního invazivního lobulárního karcinomu, skóre gradingu nádoru dle modifikované Notthinghamské klasifikace je 3+3+1=7, střední diferenciace, G2. Myoepitélie v p63 nejsou zastiženy. V PAS nález obdobný.

Imunohistochemické vyšetření:
E-CAD (DAKO, klon NCH-38).....negativní
Ki67 (Zytomed, klon SP6).....10 %
ER (Novocastra, klon 6F11/2).....100 %
PR (Novocastra, klon 312/2).....0
Her2neu (Ventana, klon 4B5)..... HER2 negativní (skóre 0)

M1: M85203 KARCINOM LOBULARNI INFILTRUJICI G: P:1

2,4,2026 BCS + SLN l.sin.

KARCINOM LOBULARNI INFILTRUJICI + LCIS prsu sin
TNM: pT1b N0 /3/0/ Mx

Velikost tumoru: 6 mm v největším průměru (měřeno mikroskopicky)
Typ nádoru: Invazivní lobulární karcinom + LCIS (viz biopsie č. 6293/2026).
Grading nádoru: G2
Angioinvaze a invaze do lymfatik: Ne
Perineurální šíření: Ne
Resekční linie: Intaktní, karcinom je od černě barvené (kaudální) resekční plochy vzdálen **méně než 1 mm**
'levý prs - lem'
Průřezy tukově vazivovým stromatem mléčné žlázy se zastižením ložiska LCIS, které je vzdáleno od černě barvené resekční plochy 16 mm. V IHC vyšetření s protilátkami p63 a CK14 se pozitivně barví myoepiteliální lemy, protilátka CKAE1/AE3 pozitivní epitelové struktury. V řezech s protilátkami E-CAD, PR a ER se struktury LCIS vykrájely. Dále zastižena apokrinní metaplázie. Černě barvená resekční plocha je intaktní.

Imunohistochemické vyšetření (blok):
E-CAD (DAKO, klon NCH-38)..... negativní
Ki67 (Cell Marque, klon SP6)..... 5 %
ER (Novocastra, klon 6F11/2)..... 70 %
PR (Novocastra, klon 312/2)..... 0 %
Her2neu (Ventana, klon 4B5)..... 0 (ultralow)

SONO břicha a RTG plic - negat

zhojeno, stehy ex.

pacientka nenaplňuje kriteria provedení mammaprintu

Doporučení:
Indikována adjuvantní RT a HT. Termín vstupního pohovoru 2026 (bude se hlásit na recepci Onkologické kliniky)

Pacientka je poučena o charakteru onemocnění a plánu léčby, informacím rozumí, mohla klást otázky, na které jí bylo zodpovězeno.